

PARALISIA FACIAL — CENTRAL vs PERIFÉRICA

CENTRAL vs PERIFÉRICA — DISTINÇÃO FUNDAMENTAL

Característica	Periférica (VII)	Central (AVC, tumor)
Fronte (testa)	PARESIA (não fecha o olho, não franzela testa)	POUPADA (franzela a testa — inervação bilateral)
Localização da lesão	Nervo facial (VII) periférico — pós-gânglio	Via corticoespinhal — neurônio motor superior
Outros déficits	Hiperarcusia, disgeusia, lacrimejamento	Hemiplegia, afasia, disartria — HA
Início	Horas, progressiva (dias), após frio / viral	Súbito, em segundos-minutos
Urgência	TC não obrigatória se diagnóstico típico	TC/RMC urgente (AVC/tumor)

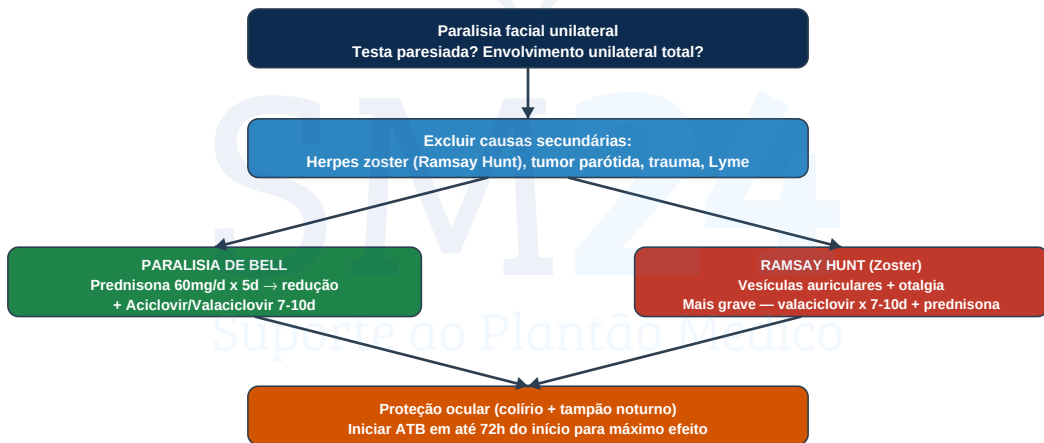
PARALISIA DE BELL — DEFINIÇÃO

IDIOPÁTICA — DIAGNÓSTICO DE EXCLUSÃO

- Paralisia facial periférica IDIOPÁTICA — mais comum (70% das PFPs)
- Causa provável: reativação do HSV-1 ou HZV no gânglio geniculado
- Incidência: 20-30 casos/100.000/ano; pico 15-45 anos; DM, gestação = risco aumentado
- Prognóstico: 71% recuperação completa espontânea; 13% sequelas leves; 4% graves
- Pior prognóstico: paralisia completa, >60 anos, DM, HAS

DIAGNÓSTICO E CONDUTA

PFP — EXCLUIR CENTRAL, TRATAR PRECOCE



CAUSAS DE PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA

Causa	Pistas diagnósticas	Conduta específica
Bell (idiopática)	Diagnóstico de exclusão, evolução típica	Prednisona + aciclovir em <72h
Ramsay Hunt (HZV)	Vesículas auriculares/canal + otalgia + hipoacusia	Valaciclovir 1g 3x/d x 7d + prednisona
Tumor de parótida	Massa palpável, instalação progressiva	TC/USG parótida + encaminhar Cir. C&P
Sarcoidose	Uveíte, adenopatia hilar, hifadropatia	PCA, ECA, biópsia; corticoide
Doença de Lyme	Exposição à carrapato, eritema migratório	Doxiciclina 100mg 12/12h x 21d
Fratura temporal	Trauma craniano, otorragia, hemotímpano	TC temporal; ORL urgente

TRATAMENTO DA PARALISIA DE BELL

JANELA DE 72 HORAS

- Prednisona 60-80 mg/d VO por 5 dias → redução gradual até 10 dias total (aumenta recuperação de 57% para 83%)
- Aciclovir 400 mg 5x/d OU valaciclovir 1g 3x/d por 7-10 dias (benefício incerto, mas recomendado)
- Iniciar em até 72h do início dos sintomas para máxima eficácia
- PROTEÇÃO OCULAR: lágrima artificial de hora em hora + colírio noturno + tampão oclisor à noite (risco de ceratopatia por exposição)
- Fisioterapia facial: iniciar após 2-3 semanas para prevenir sequelas musculares
- Eletroneuromiografia (ENMG): indicada se sem melhora em 3-4 semanas para prognóstico

SEGUIMENTO E PROGNÓSTICO

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

- ☐ Informar: maioria recupera completamente em 3-6 meses
- ☐ Retornar se: não melhora em 3 semanas, piora, déficit contralateral, febre, dor intensa
- ☐ Sincinesias (movimentos involuntários): podem surgir na recuperação (reabilitação facial)
- ☐ DM e gestação: mesmo tratamento; evitar doses altas de corticoide em gestantes (<34 semanas)
- ☐ Sequelas graves (<5%): contratura, sincinesias, crocodile tears (lacrimejamento ao comer)
- ☐ Cirurgia de descompressão: raramente indicada (<10% das pontas de desnervação)

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Qual característica distingue a paralisia facial PERIFÉRICA da CENTRAL (por AVC)?

- A) Déficit apenas no terço inferior da face, com preservação da testa, na periférica
- B) Déficit em toda a hemiface (incluindo testa) na periférica; testa poupada na central
- C) A paralisia periférica sempre causa hemiplegia contralateral
- D) Paralisia central envolve toda a face incluindo a testa
- E) Não há diferença clinicamente relevante entre as duas

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tratamento de PRIMEIRA LINHA na Paralisia de Bell, iniciado em até 72 horas do início?

- A) Metilprednisolona IV 1g/dia por 3 dias
- B) Fisioterapia facial imediata + calor local
- C) Prednisona 60-80 mg/d VO com redução gradual em 10 dias
- D) Aciclovir isolado sem corticoide
- E) Cirurgia de descompressão do nervo facial

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente com paralisia facial periférica, vesículas no pavilhão auricular, otalgia intensa e hipoacusia. Qual é o diagnóstico?

- A) Paralisia de Bell idiopática
- B) Síndrome de Ramsay Hunt (Herpes Zoster)
- C) Otite média complicada
- D) Tumor de parótida
- E) Síndrome de Melkersson-Rosenthal

QUESTÃO 4

SES-RJ / Adaptada

Por que a proteção ocular é essencial na paralisia facial periférica?

- A) O olho fica sensível à luz solar intensa
- B) A lagofthalmia (incapacidade de fechar o olho) expõe a córnea, com risco de ceratopatia por exposição e úlcera
- C) A paralisia causa hiperemia conjuntival irreversível
- D) Para evitar estrabismo durante a recuperação
- E) Para reduzir a pressão intraocular aumentada

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

Em um jovem com paralisia facial periférica e histórico de caminhada em área de mata com eritema migratório, qual diagnóstico deve ser investigado?

- A) Paralisia de Bell idiopática
- B) Sarcoidose
- C) Doença de Lyme (Borrelia burgdorferi)
- D) Síndrome de Guillain-Barré
- E) Mononucleose infecciosa (EBV)

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Periférica: toda a hemiface (incluindo testa) — porque o núcleo do VII recebe inervação bilateral para a parte superior, mas a lesão periférica elimina TODA inervação ipsilateral. Central (AVC): testa POUPADA porque a inervação supranuclear é bilateral para a frente.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Prednisona 60-80mg/d VO em 10 dias (redução gradual) é o tratamento de escolha com maior nível de evidência (aumenta recuperação completa de ~57% para ~83%). Deve ser iniciado em até 72h. Aciclovir é adjuvante (benefício incerto).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Síndrome de Ramsay Hunt: PFP + vesículas no pavilhão auricular/canal auditivo + otalgia + hipoacusia/zumbido. É reativação do HZV no gânglio geniculado. Pior prognóstico que Bell. Trata-se com valaciclovir + corticoide.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Lagofthalmia = incapacidade de fechar completamente o olho. A córnea fica exposta, ressecada e sujeita a abrasão e úlcera (ceratopatia de exposição). Tratamento: lágrima artificial, colírio noturno e tampão oclutor à noite.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Doença de Lyme por *Borrelia burgdorferi* pode causar neuroborreliose com PFP (uni ou bilateral). Pesquisar: exposição a carrapatos, eritema migratório. Diagnóstico: sorológica (ELISA + Western blot). Tratamento: doxiciclina 100mg 12/12h por 21 dias.

SM24
Suporte ao Plantão Médico